

TEMA 7.21 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Trastornos de Personalidad: Clúster A y B

PERFIL EUNACOM 1.09.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a la Personalidad

La **personalidad** se define como la forma de ser de un individuo; es el conjunto de rasgos y características que determinan cómo una persona se relaciona consigo misma y con los demás. Estos rasgos se consolidan durante la niñez y la adolescencia, estableciendo patrones de conducta estables en la adultez.

Se estima que aproximadamente el **10% de la población** padece algún trastorno de personalidad. Es fundamental distinguir entre "rasgos de personalidad" (presentes en todos) y un "trastorno".

¿Qué es un Trastorno de Personalidad?

Es una forma de ser infrecuente, poco común y, sobre todo, **patológica**. Se caracteriza por generar disfunción en las relaciones interpersonales y conductas desadaptativas.

NOTA CLÍNICA

Egosintonía: Una característica clave de estos trastornos es que son **egosintónicos**. Esto significa que el paciente no identifica su forma de ser como el problema. Por el contrario, percibe que los demás son los culpables de sus conflictos o que el mundo exterior es el que debe cambiar.

Clasificación por Clústeres

Los trastornos de personalidad se agrupan en tres categorías o "clústeres" según sus características predominantes:

TABLA 7.21.1: CLÚSTER VS DENOMINACIÓN COMÚN

CLÚSTER	DENOMINACIÓN COMÚN	TRASTORNOS INCLUIDOS
Clúster A	"Psicóticos" (Raros o excéntricos)	Paranoide, Esquizoide, Esquizotípico.
Clúster B	"Anímicos" (Dramáticos o erráticos)	Antisocial, Límitrofe (Borderline), Narcisista, Histriónico.
Clúster C	"Ansiosos" (Temerosos)	Evitativo, Dependiente, Obsesivo-Compulsivo.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Aunque se llamen "psicóticos", "anímicos" o "ansiosos", **no son un cuadro de Esquizofrenia, Depresión o Trastorno de Pánico** per se, sino que comparten un estilo o tendencia que recuerda a esas patologías.

Clúster A: Los Raros o Excéntricos

1. Trastorno Paranoide

Se caracteriza por una **desconfianza generalizada**, celos y rencor. - Desconfía de la fidelidad de la pareja y de la lealtad de amigos (jamás cuenta secretos). - Percibe significados ocultos o ataques en comentarios inocentes. - Entra en conflictos y peleas fácilmente al sentirse ofendido. - **Importante:** No hay pérdida del juicio de realidad (no es un delirio paranoide), la desconfianza se mantiene dentro de los límites de lo posible.

2. Trastorno Esquizoide

Se define como el "ermitaño". Es una persona **indiferente, fría y plana**. - No tiene amigos ni pareja, pero no por rechazo social, sino por **falta de interés**. - No disfruta de las relaciones interpersonales, ni siquiera con su familia. - Es indiferente a las críticas y a los halagos. - Tiene **mal pronóstico** terapéutico debido a su falta de motivación para el cambio.

3. Trastorno Esquizotípico

Anteriormente clasificado como trastorno de personalidad, hoy se considera parte del espectro de la **Esquizofrenia**. - Presenta **ideas de referencia** (creer que eventos externos tienen un mensaje personal). - Comportamiento, lenguaje y creencias excéntricas o raras.

Clúster B: Los Dramáticos y Emocionales

1. Trastorno Antisocial

Es el cuadro más grave en términos de impacto social. Se caracteriza por el desprecio a las normas. - **Conducta:** Cruel, mentiroso, deshonesto y propenso a delinquir. - **Psicopatología:** Falta de empatía y ausencia de remordimientos. Solo se "arrepiente" cuando recibe una sanción externa (cárcel). - **Pronóstico:** Malo, aunque puede mejorar con el paso de los años si hay una intervención multidisciplinaria intensiva.

2. Trastorno Narcisista

Se define por la **autograndiosidad** y la necesidad de admiración. - Fantasías de éxito ilimitado. - **Explotación interpersonal:** Se aprovecha de los demás porque se siente superior y digno de privilegios. - **Envidia:** Es muy envidioso y cree que el resto lo envidia a él (mecanismo de defensa). - A diferencia de la Manía en el **Trastorno Bipolar**, el narcisismo es un rasgo crónico y estable.

3. Trastorno Límitrofe (Borderline)

Es uno de los más frecuentes en la consulta clínica por su alta inestabilidad. - **Relaciones:** Intensas pero inestables (pasan de la idealización a la devaluación extrema). - **Miedo al abandono:** Esfuerzos desesperados para evitar que los dejen. - **Identidad:** Autoimagen muy inestable ("personalidad escindida"). - **Impulsividad:** Ira descontrolada y conductas de riesgo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El Trastorno Límitrofe es el que presenta mayor riesgo de **autoagresión** (cortes) e **intentos de suicidio**. Su impulsividad los hace altamente vulnerables a consumir el acto suicida.

4. Trastorno Histriónico

Busca ser constantemente el **centro de atención**. - Emociones cambiantes, exageradas y teatrales. - Muy preocupado por la apariencia física y conducta seductora. - Altamente influenciable por los demás y superficial en sus vínculos.

Clúster C: Los Ansiosos y Temerosos

1. Trastorno Evitativo

Se siente **inferior e inepto**. A diferencia del esquizoide, el evitativo **sí quiere** tener amigos, pero no lo intenta por miedo. - Ansiedad extrema ante el rechazo. - Retraimiento social por sentimientos de inadecuación. - **Pronóstico:** Bueno con psicoterapia y coaching, ya que sufren por su soledad y desean el cambio.

TABLA 7.21.2: DIFERENCIA CLAVE VS TRASTORNO ESQUIZOIDE

DIFERENCIA CLAVE	TRASTORNO ESQUIZOIDE	TRASTORNO EVITATIVO
Deseo social	No le interesa, prefiere estar solo.	Sí quiere socializar, pero tiene miedo.
Causa de soledad	Indiferencia.	Miedo al rechazo/sentirse inferior.

2. Trastorno Dependiente

Marcada inseguridad y necesidad de que otros tomen decisiones por ellos. - Delega responsabilidades vitales en terceros. - No expresa desacuerdo por miedo a perder el apoyo o ser abandonado. - Capaz de realizar tareas desagradables o sumisas solo para mantener el vínculo.

Diagnóstico y Manejo General

Diagnóstico

El diagnóstico de todos los trastornos de personalidad es **absolutamente clínico**, basado en la historia de vida, el patrón de relaciones interpersonales y la observación de rasgos desde la adolescencia.

Tratamiento

1. **Psicoterapia:** Es el pilar fundamental. El objetivo es moldear conductas, desarrollar habilidades sociales y mejorar la autorregulación emocional. 2. **Farmacoterapia:** En general, **no responden bien a fármacos** para "curar" la personalidad. Los medicamentos se usan solo para manejar síntomas específicos o comorbilidades (ej. impulsividad, síntomas depresivos o ansiosos). 3. **Pronóstico:** - **Difícil:** Esquizoide (falta de interés), Paranoide (desconfía del terapeuta) y Antisocial (falta de ética/empatía). - **Favorable:** Evitativo y Dependiente (hay mayor sufrimiento egodistónico que motiva el cambio).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, recuerda que ante la sospecha de un trastorno de personalidad con riesgo vital (como el Límitrofe) o compromiso legal (Antisocial), la conducta siempre incluye la **derivación a especialista** y el manejo multidisciplinario.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 35 años acude porque "nadie lo entiende en el trabajo". Refiere que sus compañeros son "retrasados y envidiosos" y que su jefe le tiene miedo porque sabe que él es más inteligente. Se siente superior a todos. No tiene síntomas afectivos ni psicóticos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos de Personalidad: Clúster A y B. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los trastornos de personalidad son egosintónicos: el paciente culpa a los demás de sus problemas relacionales, no se ve a sí mismo como el problema.
- El esquizoide no tiene amigos ni pareja porque no le interesa (no por miedo al rechazo); es indiferente a críticas y halagos.
- El paranoide es desconfiado, celoso y rencoroso, pero NO psicótico; diferencia con el trastorno delirante paranoide.
- El antisocial incumple normas, es agresivo, sin empatía ni remordimientos; el mayor riesgo es evolucionar a conducta delictiva crónica.
- El límitrofe (borderline): relaciones intensas e inestables + impulsividad + autoagresiones + lucha contra el abandono. Mayor riesgo de suicidio.
- El narcisista: arrogante, explotador, envidioso, requiere admiración; diferencia con la manía: el narcisismo es crónico, la manía es episódica.
- El tratamiento de todos los trastornos de personalidad es psicoterapia; los fármacos son adyuvantes para comorbilidades.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS DE PERSONALIDAD: CLÚSTER A Y B)**PREGUNTA 1**

Hombre de 35 años acude porque "nadie lo entiende en el trabajo". Refiere que sus compañeros son "retrasados y envidiosos" y que su jefe le tiene miedo porque sabe que él es más inteligente. Se siente superior a todos. No tiene síntomas afectivos ni psicóticos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Trastorno bipolar en hipomanía
- B)** Trastorno de personalidad narcisista
- C)** Trastorno de personalidad paranoide
- D)** Trastorno delirante megalomaniaco
- E)** Trastorno de personalidad antisocial

PREGUNTA 2

Mujer de 24 años es traída por tercera vez a urgencias por autolesiones superficiales en los brazos. Sus relaciones de pareja son muy intensas: pasa de "este es el amor de mi vida" a "lo odio, me traicionó" en días. No tiene ningún diagnóstico previo. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Trastorno histriónico de la personalidad
- B)** Trastorno de personalidad límitrofe
- C)** Trastorno bipolar de ciclos rápidos
- D)** Trastorno de personalidad dependiente
- E)** Depresión mayor con autolesiones

PREGUNTA 3

Hombre de 45 años vive solo y trabaja como programador. Refiere que nunca ha tenido pareja ni amigos, que no le interesa relacionarse con otras personas y que las críticas y halagos de los demás le son completamente indiferentes. No está angustiado por su situación. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Trastorno de personalidad evitativo
- B)** Trastorno del espectro autista en adulto
- C)** Trastorno de personalidad esquizoide
- D)** Fobia social; ISRS
- E)** Depresión crónica (distimia)

RESUMEN: TRASTORNOS DE PERSONALIDAD: CLÚSTER A Y B

Los trastornos de personalidad son patrones de conducta rígidos, crónicos desde la adolescencia, que generan malas relaciones interpersonales. Su característica principal es ser egosintónicos: el paciente no se identifica a sí mismo como el problema sino que culpa a los demás. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es psicoterapia. Los fármacos son de escaso beneficio para la forma de ser en sí, aunque pueden usarse para comorbilidades. Se clasifican en 3 clústeres según su similitud clínica con otras patologías. Clúster A (similitud con psicosis, sin psicosis real): el esquizoide es indiferente, ermitaño, sin amigos ni pareja por elección (no por miedo al rechazo), sin importarle las críticas ni los halagos. El paranoide es desconfiado, celoso, rencoroso, interpreta significados ocultos y se siente atacado fácilmente, pero no está psicótico. Mal pronóstico en ambos. Clúster B (similitud con trastornos del ánimo): el antisocial es el más grave, incumple la ley, es deshonesto, agresivo, sin empatía ni remordimientos, irresponsable. El narcisista es arrogante, autograndioso, explotador, envidioso y requiere admiración constante. El límitrofe (borderline) tiene relaciones intensas e inestables, labilidad emocional, impulsividad, autoagresiones y lucha desesperada contra el abandono. El histriónico quiere ser el centro de atención, es exagerado, superficial, seductor e influenciable. Los del clúster B se asocian a mayor riesgo de suicidio (especialmente límitrofe y antisocial) y a complicaciones con depresión. El tratamiento es psicoterapia; algunos tienen buena respuesta (límitrofe, evitativo) con tratamientos especializados (terapia dialectico-conductual).